RUTA CLÍNICA: SÍNDROME CORONARIO CRÓNICO

Hospital Regional de Moniquirá E.S.E
Crecemos para cuidar tu Salud!

1. INGRESO DEL PACIENTE

REGISTRAR EN HISTORIA CLÍNICA

Características del dolor:
- -Angina Típica o Atípica
- -Equivalentes Anginosos:
  - -Desencadenado por estrés emocional
  - -Disnea o mareo durante el esfuerzo
  - -Dolor en brazos, mandíbula, cuello o parte superior de la espalda
  - -Fatiga

Riesgo Cardiovascular
- -Hipertensión
- -Diabetes
- -Tabaquismo (actual ó previo)
- -Dislipidemia
- -Antecedentes familiares
  - -Hombres < 55 y mujeres < 65 años de edad con ECV temprana o muerte súbita

EXAMEN FÍSICO COMPLETO

PARACLÍNICOS

- -EKG (ondas Q, W, Bloqueos)
- -Función pulmonar (si lo amerita por clínica)
- -Perfil lipídico (HDL, LDL, TG, CT)
- -Glucosa en ayunas/HbA1c
- -Función tiroides (si no tenía previamente)
- -Función renal (creatinina)
- -Hemograma tipo IV

SOSPECHA DE SCA DERIVAR A URGENCIAS

2. CALCULAR PROBABILIDAD DE ENFERMEDAD CORONARIA OBSTRUCTIVA CRÓNICA

1. Escala de puntos (0-3 puntos)

Características del dolor torácico	
Tipo y localización	Dolor opresivo localizado en la región retroesternal o en el cuello, la mandíbula o el brazo (1 punto)
Agravado por	Estrés físico o emocional (1 punto)
Se alivia con	Reposo o nitratos en los primeros 5 min (1 punto)
Características de la disnea	
Falta de aire y/o dificultad para tomar aire durante el esfuerzo físico (2 puntos)	

Escala de síntomas: Síntomas principales: Dolor torácico (0-3 puntos) o Disnea (2 puntos)

2. Número de factores de riesgo de EAC (0-5): Historia familiar, tabaquismo, dislipemia, hipertensión y diabetes

3. Probabilidad clínica ponderada por factores de riesgo (RF-CL) de EAC obstructiva

Escala de síntomas

Número de factores de riesgo	0-1 puntos		2 puntos		3 puntos	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
	0-1 2-3 4-5	0-1 2-3 4-5	0-1 2-3 4-5	0-1 2-3 4-5	0-1 2-3 4-5	0-1 2-3 4-5
Edad 30-39	0 1 2	1 2 5	0 1 3	2 4 8	2 5 10	9 14 22
Edad 40-49	1 1 3	2 4 8	1 2 5	3 6 12	4 7 12	14 20 27
Edad 50-59	1 2 5	4 7 12	2 3 7	6 11 17	6 10 15	21 27 33
Edad 60-69	2 4 7	8 12 17	3 6 11	12 17 25	10 14 19	32 35 39
Edad 70-80	4 7 11	15 19 24	6 10 16	22 27 34	16 19 23	44 44 45

Probabilidad clínica: Muy baja · Baja · Moderada

Tomada de ESC 2024: Guía sobre el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes coronarios crónicos

3. CONDUCTA POR PROBABILIDAD

- **Muy Baja ≤ 5%** → -No más pruebas cardiacas -Considerar otro diagnóstico
- **Baja 5 - 15%** → -Score de Calcio Coronario -Prueba de esfuerzo -Detección de enfermedad aterosclerótica
- **Moderada >15 - 50%** → -Angio-TAC Coronario -Derivar a Cardiología -Pruebas funcionales

4. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS*

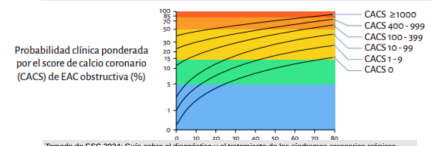
ECO-TT: Descartar otras causas de dolor torácico
- -Insuficiencia Cardiaca, valvulopatías, miocardiopatías

Ante sospecha de Vasoespasmo o Arritmia
- - Realizar Holter 24 horas

5. RECLASIFICAR PROBABILIDAD

2. Ajuste la probabilidad clínica en base a resultados clínicos anormales (Clase I)
- Cambios en el ECG en reposo (cambios en la onda Q o en el segmento ST/onda T)
- ECG de esfuerzo con resultados anormales
- Disfunción del VI (severa o segmentaria)
- Arritmia ventricular
- Enfermedad arterial periférica
- Calcificación coronaria en TC torácica previa

3. Considere la reclasificación de la RF-CL baja (> 5-15%) mediante la determinación del CACS para identificar una CACS-CL muy baja (≤ 5%) (Clase IIa)



Tomada de ESC 2024: Guía sobre el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes coronarios crónicos

- **Alta > 50 - 85%** → -Eco-Stress-PET, SPECT o RMC -Derivación a Cardiología
- **Muy Alta > 85%** → -Hemodinamia -> Coronariografía invasiva

Indicación de Coronariografía Invasiva
- -Alta probabilidad clínica (>85%) con síntomas graves o refractarios
- -Síntomas sugestivos con nivel bajo de ejercicio
- -FEVI que sugiera una enfermedad coronaria extensa
- -Angio-TAC muestra estenosis ≥ 50% en el tronco común izquierdo o estenosis ≥ 70% en el segmento proximal de la rama descendente anterior

*Por Especialista: Médico General debe remitir para continuar estudios

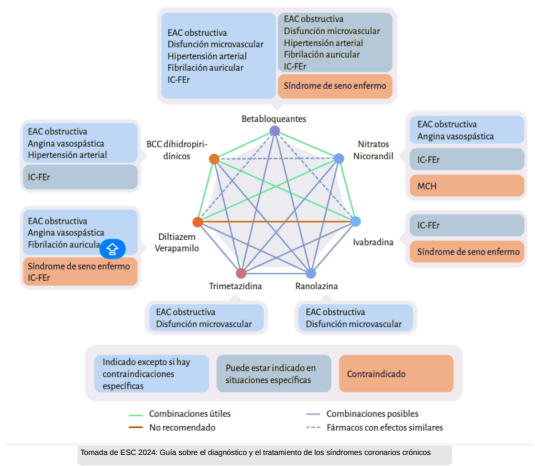
6. TRATAMIENTO

INICIAL
- Intervención en estilos de vida
- Tabaquismo y SPA → Medidas no Farmacológicas y Farmacológicas
- Obesidad y Sobrepeso → IMC 18,5-25 (Considerar manejo farmacológico o quirurgico)
- Hiperlipidemia → LDL <55mg/dL o disminución de ≥50% del basal
- Diabetes → HbA1c <7%
- Presión Arterial → PAS 120-129 mmHg
- Dieta → Grasas Saturadas <10%, Dieta Mediterranea
- Ejercicio → 30-60 min /5 días/semana

FARMACOLÓGICO - 1ra Línea → Individualizar:

Betabloqueador:
- -Usar en FEVI <40%
- -Meta de FC en reposo: 55-60 LPM
- -Precaución en pacientes con Asma, EPOC y EAP

Bloqueador de Canales de Ca
- -Dihidropiridínicos (Amlodipino, Nifedipino): Útiles para la hipertensión y la angina.
- -No dihidropiridínicos (Verapamilo, Diltiazem): Control de la FC, pero contraindicados en FEVI < 40%



Tomada de ESC 2024: Guía sobre el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes coronarios crónicos

FARMACOLÓGICO 2da Línea*

Nitratos de Acción Prolongada
- -Si persiste Angina.
- -Usar niveles bajos para evitar tolerancia.
- -No usar en miocardiopatía hipertrófica obstructiva.

→ -Mononitrato de isosorbida XR 30-120 mg/día según respuesta -Dinitrato de isosorbida 10-40 mg 2 o 3 veces/día

Ivabrabina
- -En FEVI <40%
- -No mezclar con BCC no dihidropiridinicos

→ Inicio 5 mg/12h y 3-4 semanas aumentar a 7.5 mg/12h según tolerancia (en >75 años iniciar con 2.5 mg/12h)

Trimetazidina
- -Angina persistente o refractaria

→ Liberación inmediata: 20 mg/8h Liberación modificada: 35 mg/12h

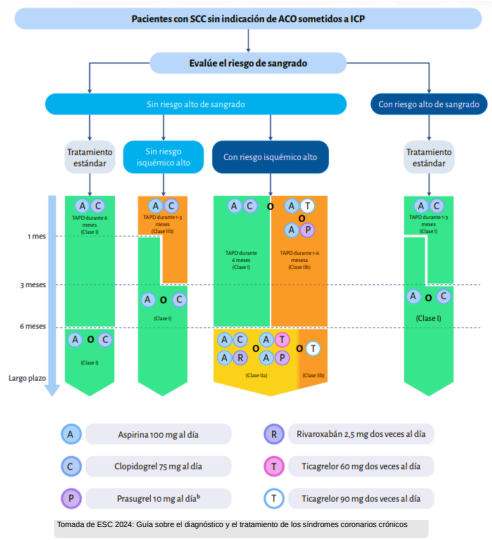
RIESGO CARDIOVASCULAR

Antiagregación
- -ASA 75-100 mg/día
- -Clopidogrel 75 mg/día

Sometidos a PCI
- -Antiagregación doble por 6 meses

7. OTRAS RECOMENDACIONES

- -SCC con stent y riesgo trombótico/isquémico: uso de prasugrel o ticagrelor hasta por 3-6 meses
- -FA: uso de DOACs
- -SCC + ICP: IP2Y12 + ASA por 12 meses
- -Riesgo de sangrado gastrointestinal: uso de IBP
- -En HTA, DM, ERC o FEVI <40%
  - - Usar IECA o ARA II
- -SCC + DM T2: iSGLT2
- -Hipolipemiantes para metas según riesgo CV



Tomada de ESC 2024: Guía sobre el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes coronarios crónicos

8. ANOCA/INOCA

-**Disfunción microvascular ->** betabloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio, trimetazidina, con el objetivo de mejorar la perfusión miocárdica y el control sintomático.
-Angina vasoespástica -> bloqueadores de los canales de calcio, los cuales reducen la vasoconstricción coronaria y previenen los episodios de espasmo.

9. REVASCULARIZACIÓN → Anatomía Coronaria de Alto Riesgo

Enfermedad del tronco coronario izquierdo (estenosis ≥ 50%)
Enfermedad coronaria de tres vasos
Enfermedad de uno o dos vasos con compromiso del segmento proximal de la arteria descendente anterior
FEVI ≤ 35% de origen isquémico, en pacientes con anatomía coronaria susceptible de revascularización

SELECCIÓN DE MODALIDAD

Depende de:
Complejidad anatómica de la enfermedad coronaria
Puntuación SYNTAX
Comorbilidades del paciente
Riesgo quirúrgico.

Cirugía de revascularización coronaria: diabetes mellitus y enfermedad coronaria multivaso compleja, o en enfermedad del tronco coronario izquierdo con puntuación SYNTAX ≥ 33.

Intervención coronaria percutánea: enfermedad del tronco coronario izquierdo de baja complejidad anatómica (SYNTAX ≤ 22) o en enfermedad de uno o dos vasos sin compromiso del segmento proximal de la DA.

Casos complejos -> Heart Team (cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista y cirujano cardiovascular)

Bibliografía:

SEC Working Group for the 2024 ESC guidelines for the management of chronic coronary syndromes and SEC Guidelines Committee. Comments on the ESC 2024 guidelines for the management of chronic coronary syndromes. Rev Esp Cardiol (Engl Ed) [Internet]. 2025;78(3):170–5. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.rec.2024.10.007